갑상선기능저하증, 올바른 치료와 관리로 건강한 삶을

갑상선기능저하증 — 갑상선 호르몬이 부족해 대사가 느려지는 상태, 꾸준한 복약과 정기 추적이 핵심입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

갑상선기능저하증이란

갑상선 호르몬이 부족해 몸의 대사가 느려지는 상태입니다

0.73%

뚜렷한 저하증

한국 성인에서 호르몬 수치가 분명히 떨어진 경우

3.1%

가벼운 경우까지

증상 없이 검사에서만 드러나는 경우를 합한 비율

6배

여성에게 더 흔함

남성보다 여성에서 훨씬 많이 생깁니다

뚜렷한 저하증 vs 가벼운(무증상) 저하증

뇌하수체 신호 호르몬(TSH)이 오르고 갑상선 호르몬(유리 T4)이 떨어지면 '뚜렷한 저하증'입니다. 가장 흔한 원인은 면역이 갑상선을 공격하는 **하시모토 갑상선염**입니다. TSH만 오르고 호르몬은 정상이면 '무증상 저하증'입니다.

TSH 결과는 이렇게 봅니다

먼저 **검사 결과지의 참고 범위**를 보세요. 우리 병원은 TSH **4.2 이상**이면 '높음'으로 표시하지만, 한국인 상한은 약 **6.8 mIU/L**입니다(시약 기준과 한국인 조사의 차이). 유리 T4가 정상이고 6.8 이하면 대개 큰 문제는 없고, 증상·임신은 함께 봅니다.

Tip · 검사 결과지의 'TSH'가 높고 '유리 T4'가 낮으면 갑상선 호르몬이 부족하다는 뜻입니다.

근거 · 대한갑상선학회(KTA) 2023 · 한국 성인 유병률

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

몸 전체가 느려지는 증상이 나타납니다

대부분 천천히 생겨 나이 탓·피로 탓으로 넘기기 쉽습니다

피로·무기력

가장 흔한 첫 증상입니다. 쉬고 잠을 늘려도 잘 회복되지 않습니다.

체중 증가

평균 2~5kg 늘어나는데 대부분 물·부기입니다. 호르몬이 정상이 되면 체중 관리도 보통 사람과 같아집니다.

추위 탐 · 맥박 느려짐

추위를 잘 타고 손발이 차며 맥박이 느려집니다.

집중력·기분 저하

기억력이 떨어지고 의욕이 줄어듭니다. 어르신은 치매로 오해받기도 합니다.

피부·머리카락 변화

피부가 건조해지고 눈 주위·손이 붓습니다. 머리카락이 가늘어지고 빠집니다.

응급 — 점액수종 혼수

의식이 흐려지거나 체온이 35.5°C 아래로 떨어지거나, 맥박이 매우 느리거나, 숨이 차거나 온몸이 심하게 부으면 **즉시 응급실**로 가세요.

Tip · 증상만으로는 알기 어렵습니다 — 의심되면 혈액검사로 확인합니다.

근거 · 미국갑상선학회(ATA) 저하증 지침 · 대한갑상선학회 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

혈액검사로 단계적으로 진단합니다

결과지 참고 범위를 먼저 봅니다



그림 · 목의 갑상선 상태를 혈액검사 수치로 확인합니다(설명용 그림).

1 TSH 검사 첫 선별

결과지 참고치를 우선 확인합니다. 한국인 연구에서 참고 범위는 약 0.6~6.8 mIU/L이며 검사법마다 다릅니다.

2 유리 T4 · 갑상선 자가항체 추가 검사

TSH가 높으면 갑상선 호르몬과 자가항체(TPO 항체)를 봐 원인을 확인합니다.

3 결과 나누기 해석

TSH↑ + 호르몬↓ = 치료 시작 · 호르몬 정상 = 2~3개월 뒤 재검 · 둘 다 낮으면 뇌하수체 쪽 원인을 봅니다.

4 치료 결정 상담

나이·증상·항체·다른 질환을 함께 봅니다. 건강보험은 검사 3종까지 적용되고 4종 이상은 본인부담 90%입니다.

Tip · 검사는 한 번으로 끝내지 않고 몇 달 간격으로 다시 보기도 합니다.

근거 · 대한갑상선학회 2023 진단 순서 · 건강보험 기준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

갑상선호르몬제(레보티록신)를 매일 먹습니다

부족한 호르몬을 채우는 표준 치료입니다 — 2주쯤 나아지기 시작해 6주면 뚜렷해지고 12주쯤 안정됩니다

1

언제 먹나요

아침 공복에 물과 함께 먹고 식사·커피는 1시간 뒤에 합니다. 저녁 식사 3시간 이상 지나 **자기 전**에 먹어도 흡수는 비슷합니다.

아침 공복 또는 자기 전

2

띄워 먹을 것

칼슘·철분제·제산제·콜레스티라민은 **4시간** 띄웁니다(임신 중 영양제도). 위산 억제제를 시작하거나 끊으면 6주 뒤 TSH를 다시 봅니다.

새 약·영양제는 진료 때 알리기

3

용량과 목표

용량은 체중·나이·심장 질환에 따라 정합니다. 치료 중 목표 TSH는 대개 **0.4~4.5 mIU/L**이고(한국인 상한 약 6.8), 어르신은 조금 높게 두며 증상·임신 여부에 따라 조정합니다.

용량은 진료 때 조정

Tip · 자세한 간격표는 갑상선약 복용법 안내문을 드립니다 — 약은 임의로 늘리거나 줄이지 마세요.

근거 · 대한갑상선학회 2023(한국인 참고치) · ATA/AACE 2012 · 광교바른내과 진료 기준(치료 목표) · 미국·유럽갑상선학회 흡수 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

혈액검사로 알맞은 용량을 맞춰 갑니다

약이 몸에 자리 잡는 데 약 5주(35일)가 걸려서, 바꾼 뒤 바로 재지 않습니다

1 첫 재검 6~8주 뒤

약을 시작하거나 용량을 바꾼 뒤 TSH를 처음 다시 잽니다.

2 안정 확인 3~6개월

용량이 맞는지 확인하고 필요하면 조금씩 조정합니다.

3 정기 추적 6~12개월마다

안정되면 1년에 한두 번 TSH를 확인하면 충분합니다.

4 다시 재야 할 때 그때그때

체중이 크게 변했을 때, 새 병이 생기거나 다른 약을 더하거나 바꿨을 때, 약 제조사가 바뀌었을 때.



그림 · 검사 수치의 흐름을 보며 용량을 조정합니다(설명용 그림).

Tip · 갑상선 기능검사 날에는 약 먹기 전에 채혈합니다.

근거 · 미국갑상선학회 장기 추적 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

가벼운 저하증은 나이와 TSH로 치료를 정합니다

모두 약을 먹는 것은 아닙니다 — 대한갑상선학회 2023 기준

약을 권하는 경우

70세 미만이고 TSH가 10을 넘으면 치료를 권합니다.

- TSH 6.8~10이면서 증상이 있거나 자가항체 양성이면 6개월 시험 치료를 고려
- 증상이 없으면 치료 없이 지켜봄
- 자가항체 양성·갑상선 질환이 있으면 1년에 한 번 TSH
- 그렇지 않으면 2~3년 간격으로 확인

VS

70세 이상은 신중히

대개 약을 권하지 않고 한 분씩 따져 봅니다.

- 약이 지나치면 심방세동·골다공증 위험
- 65세 이상 737명 연구에서 약과 가짜약의 증상·삶의 질 차이가 없었음
- 65세 이상은 4년 안에 46%가 저절로 정상으로 돌아옴
- 해마다 자가항체 양성 4.3%, 음성 2.6%가 뚜렷한 저하증으로 진행

Tip · '지켜보자'는 방치가 아니라 정해진 간격으로 다시 재는 치료 계획입니다.

근거 · 대한갑상선학회 2023 · NEJM 2017 노인 무증상 저하증 연구 · 영국 NICE

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

임신 전후에는 TSH를 더 촘촘히 봅니다

엄마의 갑상선 호르몬은 아기 발달에 중요합니다

TSH 목표

임신을 계획하면 **2.5 mIU/L 미만**을 권합니다. 임신 초기 상한은 **4.0 mIU/L**로 봅니다(미국갑상선학회 2017).

이미 약을 먹는 분

임신을 확인하면 바로 **일주일에 2회분을 더** 먹습니다(약 30% 증량). 임신 전반기에는 4주마다 TSH를 확인합니다.

치료하지 않으면

유산·조산·임신중독증·아기 신경 발달 문제 위험이 높아집니다. 출산 후에는 원래 용량으로 돌아가 6주 뒤 TSH를 봅니다.



그림 · 임신 중에는 엄마의 갑상선 호르몬이 아기에게도 쓰입니다(설명용 그림).

Tip · 출산 후 5~10%에서 산후 갑상선염이 생길 수 있어 산후 검사를 꼭 받으세요.

근거 · 미국갑상선학회(ATA) 2017 임신 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

해조류는 평소처럼 드셔도 됩니다

한국인은 요오드를 권장량의 2~5배 먹고 있어 따로 줄일 필요가 없습니다

구분	내용
괜찮습니다	김·미역·다시마 같은 해조류 · 산후 미역국 · 익힌 브로콜리·양배추 · 평소 양의 채소·과일
괜찮습니다	골고루 먹는 식사 · 약을 꾸준히 먹고 정기적으로 TSH 확인
주의하세요	다시마 농축액을 많이 먹는 것(특히 하시모토 갑상선염) · 요오드 영양제(한국 식단에는 필요 없음)
주의하세요	셀레늄 영양제(공식 권고 없음) · '천연 갑상선 추출물'을 스스로 먹는 것
하지 마세요	의사와 상의 없이 다른 갑상선 호르몬(T3)을 더하거나 약 용량을 스스로 바꾸는 것

Tip · 몸에 좋다는 영양제를 시작하기 전에 먼저 물어봐 주세요.

근거 · 대한갑상선학회 2023 한국인 요오드 섭취 · 2024 무작위 연구 종합

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

호르몬을 채우면 잘 관리되는 병입니다 — 꾸준한 복약과 정기 검사가 핵심

01 약은 아침 공복에 물과 함께, 식사·커피는 1시간 뒤

02 칼슘·철분제와는 4시간 띄우기

03 위산 억제제·제산제는 시간을 나눠서

04 용량을 바꾸면 6~8주 뒤 TSH 다시 재기

05 안정되면 6~12개월마다 확인

06 임신 계획·임신 확인 시 바로 상담

07 해조류는 평소대로, 다시마 농축액만 주의

08 의식 저하·저체온·느린 맥박·숨참은 바로 응급실

Tip · 약 봉투에 복용 시간과 다음 검사 날짜를 적어 두면 잊지 않습니다.

근거 · 광교바른내과 갑상선기능저하증 관리 계획

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

갑상선기능저하증 진단을 받았거나 약을 드시는 분을 위한 설명자료입니다. 결과지 읽는 법은 갑상선 검사 결과 안내문을 드립니다.

참고한 자료

대한갑상선학회(KTA) 2023 · 미국갑상선학회(ATA) 저하증·임신 지침 2017 · 유럽갑상선학회(ETA) · 영국 NICE 2019/2023 · NEJM 2017 노인 무증상 저하증 연구

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요